

폐암 진단 첫 30일

조직형 · 유전자검사 · 치료 순서 이해

처음 진단받은 환자와 보호자를 위한 핵심 정리 · 질문 · 행동 가이드

ApuDa 「암 진단 첫 30일」 시리즈 02

MINI 무료 배포판 · Instagram 구독자용 · 2026년 10월 개정 2판

폐암 치료는 ‘조직형’과 ‘유전자 결과’를 확인한 뒤에 정해집니다.

이 책을 펴기 전에

- 이 책은 **일반적인 환자교육 자료**입니다. 나의 병기, 치료 순서, 약 선택, 예후는 담당 의료진과 함께 결정합니다.
- 의학정보 확인일: **2026.10.04** · 참고 지침: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology — Non-Small Cell Lung Cancer / Small Cell Lung Cancer, Version 9.2026(비소세포 기준) 외 국내 자료(본문 끝 「근거와 한계」 참고)
- 약의 국내 허가·건강보험 급여 기준과 제도(산정특례·지원사업)는 자주 바뀝니다. 실제 적용 전 병원 원무과·국민건강보험공단(1577-1000)에서 다시 확인하세요.
- 이 책은 NCCN이 검토하거나 승인한 자료가 아니며, ApuDa가 독자적으로 쓴 환자교육 저작물입니다.

이 MINI판에 대하여

이 MINI판은 진단 후 첫 30일 동안 **안전하게 판단하는 데 꼭 필요한 내용만** 담았습니다. 응급 신호, 진단 직후 할 일, 병리·병기의 핵심, 치료 흐름, 진료실 질문, 한 장 요약은 완전판과 같습니다. 30일 일자별 실행 로드맵, 치료별 준비·회복 가이드, 한국 제도·보험 서류 안내, 마음 돌보기와 보호자 가이드, 워크북은 완전판에 있습니다.

PART 1. 진단 첫 주 — 정확히 알기

1장. 먼저 구분하세요: 영상 의심과 조직 확진, 비소세포와 소세포

30초 요약

- CT에서 "폐암 의심"은 아직 확진이 아닙니다. **조직(또는 세포)검사**로 확진합니다.
- 폐암은 크게 **비소세포폐암(약 85%)**과 **소세포폐암**으로 나뉘고, 치료 경로가 완전히 다릅니다.
- 비소세포폐암은 **유전자(드라이버 변이)·PD-L1 결과**가 치료를 바꿉니다. 수술 예정인 분도 마찬가지입니다.

결과지에 적힌 말	뜻	볼 곳
결절, 간유리음영(GGO), 부분고형	영상 소견. 암일 수도, 아닐 수도	담당의 확인
선암(adenocarcinoma)	가장 흔한 비소세포폐암. 유전자 변이가 흔함	4·5장
편평상피세포암	비소세포폐암. 흡연과 관련이 많음	4·5장
NSCLC, NOS	검체가 작아 세부형을 정하기 어려움	추가 검사 상의
소세포폐암(SCLC)	빨리 자라는 편. 항암·방사선 중심	10장 먼저
상피내선암·최소침습선암	아주 초기 형태	의료진에게 의미 확인

소세포폐암이라면: 2장(응급) → 10장(소세포폐암 지도) → PART 6(질문·요약)을 먼저 보세요. 유전자검사 장(5장)은 대부분 해당하지 않습니다.

흡연하지 않았는데 왜? 비흡연자 폐암, 특히 동아시아 여성의 선암에서는 EGFR 같은 유전자 변화가 흔히 발견됩니다. 대부분 한 가지 원인을 특정할 수 없고, **당신의 잘못이 아닙니다.** 흡연했던 분도 마찬가지로, 지금 중요한 것은 원인이 아니라 계획입니다.

첫 30일의 지도

순서	할 일	시기
①	조직 확진·조직형	Day 0-7
②	병기 검사(PET/CT, 뇌 MRI, 필요 시 EBUS)	Day 3-14
③	유전자(NGS)·PD-L1 결과	Day 7-21
④	수술 / 방사선·항암방사선 / 전신치료 경로 결정	Day 10-21
⑤	치료 준비·시작	Day 14-30

오늘 물어볼 질문

1. 제 결과는 확진인가요, 아직 의심 단계인가요?
2. 비소세포폐암인가요, 소세포폐암인가요? 세부 조직형은요?
3. 치료를 정하기 전에 어떤 검사 결과가 더 필요한가요?

2장. 기다리지 않는 신호

⚠ 응급 상자 — 바로 연락하거나 응급실로

- **피를 한 손가락 이상 뱉거나 객혈이 반복될 때**(컵 단위로 많으면 즉시 119), 갑자기 심해진 숨참·흉통
- **얼굴·목·팔이 붓고 목 혈관이 튀어나옴**(상대정맥 증후군)
- **등 통증 + 다리 힘 빠짐·감각 저하·소변을 못 봄**(척수 압박)
- **갑작스러운 혼동·심한 졸림·헛소리** — 보호자가 보기에 평소와 다름 (고칼슘혈증·저나트륨혈증·뇌 전이 가능성)
- 심한 두통·구토·경련·한쪽 마비
- 항암 중 **38°C 이상 발열** — 해열제보다 먼저 연락
- 방사선·면역치료 뒤(몇 주~몇 달 후에도) **새 기침·숨참·발열**
- 스스로를 해치고 싶은 생각 → ☎ 109, 119

본문 목록:

1. 많은 객혈·급성 호흡곤란은 즉시 응급 평가가 필요합니다.
2. 얼굴·목 부종은 큰 정맥이 눌린 신호일 수 있습니다.
3. 등 통증과 신경 증상은 척추 전이에 의한 압박일 수 있어 시간이 중요합니다.
4. 혼동·졸림은 혈중 칼슘·나트륨 이상이나 뇌 전이일 수 있습니다.
5. 항암 중 발열은 감염 가능성이 있습니다.
6. 치료 후 새 기침·숨참은 방사선 폐렴·면역치료 폐렴일 수 있습니다.

첫 치료 전에: 진료실·야간 연락처·응급실을 저장하세요.

3장. 진단 뒤 72시간

30초 요약: 오늘은 ① 조직검사 결과와 예정 검사 확인 ② 폐암 진료팀 (호흡기내과·흉부외과·종양내과) 예약 ③ 흡연 중이면 금연 지원 요청.

오늘 할 일 (3개)

- ☐ 조직검사 결과·조직형 확인(아직이면 결과 예정일 확인)
- ☐ 폐암 다학제 진료가 가능한 진료팀 예약
- ☐ 흡연 중이면 금연 지원 요청(☎ 1544-9030, 보건소 금연클리닉) — 수술 합병증과 치료 효과에 영향

이번 주 할 일

- ☐ PET/CT, 뇌 MRI 일정 ☐ 폐기능 검사(수술·방사선 대상) ☐ 필요 시 EBUS(기관지 내시경 초음파) 일정
- ☐ 유전자검사(NGS)·PD-L1 의뢰 여부와 결과 예정일 확인
- ☐ 산정특례 신청(확진일로부터 30일 이내 신청 시 확진일부터 적용)
- ☐ 2차 소견 예정이면 슬라이드·블록, 영상 CD(DICOM) 준비
- ☐ 복용 약·한약·건강기능식품 목록 정리 — 새로 시작하거나 항응고제를 스스로 끊지 말고 의료진과 상의

보호자 몫

- ☐ 진료 기록 ☐ 숨참·혼동 같은 변화 관찰 ☐ 흡연 이야기로 환자를 탓하지 않기

오늘 물어볼 질문

1. 제 조직검사 결과와 남은 검사 일정은 어떻게 되나요?
2. 유전자검사와 PD-L1 검사는 의뢰됐나요? 결과는 언제 나오나요?
3. 치료 시작까지 대략 얼마나 걸리나요?

4장. 병기와 검사

30초 요약: 병기는 종양 크기(T)·림프절(N)·전이(M)로 정합니다. **PET/CT**는 몸 전체를, **뇌 MRI**는 뇌 전이를, **EBUS·종격동경**은 가슴 안 림프절을 조직으로 확인합니다.

검사	목적	기억할 점
흉부 CT	종양·림프절	기본
PET/CT	림프절·원격전이	염증·결핵도 밝게 보일 수 있어 조직 확인이 필요할 수 있음
뇌 MRI	뇌 전이(2기 이상·증상 시 등)	가능하면 조영 MRI
EBUS·종격동경	종격동 림프절 조직 확인	PET에 이상이 없어도 종양 위치·크기에 따라 시행
EBUS·종격동경	종격동 림프절 조직 확인	PET에 이상이 없어도 종양 위치·크기에 따라 시행. EBUS는 대개 전신마취 없이(진정 상태로), 종격동경은 전신마취로 함
폐기능·운동 검사	수술·방사선을 견딜 수 있는지	수술 범위 결정

병기	쉬운 뜻	흔한 치료 축
1기	작은 종양, 림프절 없음	수술(또는 정위체부방사선 SBRT)
2기	더 크거나 가까운 림프절	수술 ± 수술 전후 약물치료

병 기	쉬운 뜻	흔한 치료 축
3기	종격동 림프절 등 국소진행	수술 가능하면 수술 + 약물 / 불가하면 항암방사선 → 공고요법
4기	원격전이(반대쪽 폐·흉막·뼈· 뇌·간 등)	유전자·PD-L1에 따른 전신치료 ± 국소치료

- 작은 결절은 위치에 따라 수술 전 조직검사 없이 **수술로 떼어 진단과 치료를 함께** 하는 경우도 있습니다. 이유를 물어보세요.
- 기관지 내시경으로 닿기 어려운 결절은 CT를 보면서 가슴 피부로 가는 바늘을 넣어 조직을 얻기도 합니다(경피적 폐 조직검사). 대개 금식이 필요하고 기흉(폐 밖으로 공기가 새는 것)이나 출혈이 생길 수 있습니다. 혈액을 묽게 하는 약은 미리 알리고, 검사 뒤 숨참·흉통이 생기면 바로 연락하세요.

 **완전판에서 이어집니다** — 판독지 용어 사전, 수술 범위별 비교

검사 체크: 흉부 CT ☐ · PET/CT ☐ · 뇌 MRI ☐ · EBUS/종격동경 ☐ · 폐기능 ☐

5장. 유전자(드라이버 변이)와 PD-L1

30초 요약

- 비소세포폐암(특히 선암)은 **EGFR·ALK·ROS1·KRAS G12C·BRAF V600E·MET·RET·HER2·NTRK** 등을 넓게 검사합니다(NGS).
편평상피암도 흡연력·검체에 따라 검사할 수 있습니다.
- **수술을 앞둔 경우에도** EGFR·ALK·PD-L1 결과가 수술 전후 약 선택을 바꿉니다.
- **결과 대기 원칙:** 전이성에서는 유전자 결과가 나오기 전에 면역치료를 서둘러 시작하지 않는 것이 일반적입니다. 증상이 급하면 기다리는 동안의 계획을 상의하세요.

검사	의미	치료 범주(국내 허가·급여 확인 필요)
EGFR(엑손19 결손, L858R 등)	비흡연·동아시아 선암에서 흔함(국내 비소세포폐암의 약 30% 안팎)	먹는 표적치료제 단독 또는 병용
EGFR(엑손19 결손, L858R 등)	비흡연·동아시아 선암에서 흔함(국내 비소세포폐암의 약 30% 안팎)	먹는 표적치료제 단독 또는 병용 (국내에서 흔히 듣는 예: 오시머티닙, 국내 개발 약인 레이저티닙)
ALK·ROS1 융합	젊은 비흡연자에서 비교적 흔함	먹는 표적치료제
KRAS G12C, BRAF V600E, MET, RET, HER2, NTRK	드문 변이	각각에 맞는 표적치료 범주
PD-L1(TPS)	면역치료 반응 가능성 지표	1% 미만 / 1~49% / 50% 이상으로 나눠 해석

- 결과는 검사 종류에 따라 **수일~수주** 걸립니다.

- 조직이 부족하면 **혈액(액체생검)**으로 보완하기도 합니다.
- 변이 이름 뒤의 세부 표기(예: 엑손19, G12C)까지 그대로 적어 두세요.

 **완전판에서 이어집니다** — 바이오마커별 카드와 결과 대기 중 계획표

결과 기록

EGF	AL	ROS	KRA	BRA	ME	RE	HER	NTR	PD-L1
R	K	1	S	F	T	T	2	K	TPS

%

오늘 물어볼 질문

1. 어떤 유전자 검사를 했고 결과는 언제 나오나요?
2. 제 결과로 표적치료·면역치료 중 무엇이 해당되나요?
3. 결과를 기다리는 동안 증상은 어떻게 관리하나요?

PART 2. 치료 결정 — 2~3주차

6장. 치료 경로 지도(비소세포폐암)

30초 요약: 수술 가능한 비소세포폐암은 **수술 + (종양 크기·림프절·유전자에 따라) 수술 전·후 또는 전후 약물치료**가 표준 범주입니다. 절제 불가 3기는 **항암방사선 → 공고요법**, 4기는 **유전자·PD-L1 기반 전신치료**입니다.

상황	치료 범주(국내 허가·급여 확인 필요)
1기, 작은 종양	수술 후 경과관찰이 많음. 수술이 어려우면 SBRT
2~3기 일부 수술 가능(종양 약 4cm 이상 또는 림프절 양성)	수술 전 항암 + 면역치료 , 또는 수술 전후(주변수술기) 면역치료, 또는 수술 후 항암 ± 면역치료. 면역치료 전 EGFR·ALK 확인
EGFR 양성 수술 후	표적 보조요법 (면역치료 대신)
ALK 양성 수술 후	표적 보조요법
3기 절제 불가	동시 항암방사선 → 면역 공고요법 (약 1년), EGFR 양성은 표적 공고요법
4기 드라이버 변이 있음	해당 표적치료(단독 또는 병용)
4기 드라이버 변이 없음	면역치료 단독(PD-L1 높음) 또는 항암 + 면역치료
4기 국소 증상	통증·뇌 전이·출혈 등에 방사선 병행

국내 진료 기록이나 설명에서는 4기 전신치료를 '고식적 항암' 또는 '완화적 항암'이라고 부르기도 합니다. 치료를 포기한다는 뜻이 아니라, 암을 조절하며 오래·편하게 지내는 것이 목표라는 뜻입니다.

■ **완전판에서 이어집니다** — 수술 전후 치료 의사결정 시트, 시나리오(가상 사례)

오늘 물어볼 질문

1. 제 병기에서 수술이 가능한가요? 수술 전후 약물치료가 필요한가요?
2. EGFR·ALK 결과가 제 치료 순서를 바꾸나요?
3. 다학제 진료에서 상의했나요?

7장. 수술

30초 요약: 대부분 흉강경·로봇으로 수술하며, 폐엽절제가 표준 범위입니다. 수술 전 **금연과 호흡 운동**이 회복을 돕습니다.

■ **완전판에서 이어집니다** — 수술 전 2주 체크리스트, 입원~퇴원 후 6주 회복 달력

수술 후 퇴원했다면: 38°C 이상 발열, 숨참 악화, 상처 고름, 피 섞인 가래 증가는 연락합니다.

8장. 방사선치료

30초 요약: 방사선은 ① 수술 대신 근치(SBRT, 보통 3~8회) ② 3기 항암방사선(약 6주) ③ 증상 완화(통증·뇌 전이 등) 세 역할을 합니다.

- 흔한 부작용: 피로, 식도염(삼킬 때 통증), 피부 자극, 기침.

- **방사선 폐렴**은 치료가 끝나고 몇 주~몇 달 뒤 생길 수 있습니다. 새 기침·숨참·발열을 알려주세요.
- **삼킬 때 통증으로 물·음식을 못 삼키면** 연락합니다.

9장. 전신치료: 항암·표적·면역

범주	대표 부작용	바로 연락
항암화학요법	메스꺼움, 백혈구 감소, 피로	38°C 이상 발열
표적치료(먹는 약)	발진, 손발톱 주위염, 설사, 간수치, 드물게 폐렴	새 숨참·기침
면역치료	피부·갑상선·장·간·폐·심장 등 면역 부작용 (몇 달 뒤에도)	심한 설사, 숨참, 흉통, 심한 피로

■ **완전판에서 이어집니다** — EGFR 양성 4기 생활 가이드, 면역치료 부작용 카드

10장. 소세포폐암 지도

30초 요약

- **제한기**(한쪽 가슴과 주변 림프절): 항암 + 흉부 방사선(가능하면 동시) → **면역 공고요법** 범주. 아주 작은 경우 수술도 가능.
- **확장기**: 항암 + 면역치료 → 면역 유지. 진행 시 **이중특이항체** 등 새 치료 범주(국내 허가·급여 확인 필요).
- 뇌 전이 예방: **예방적 뇌 방사선(PCI)** 또는 정기 뇌 MRI 추적 — 장단점(기억력 영향 등)을 상의합니다.
- 소세포폐암은 바이오마커 검사가 일반적으로 1차 치료를 바꾸지 않습니다.

진행·전으로 진단받았다면

30초 요약

- 전이가 있어도 치료 선택지는 있습니다. 치료 목표가 **암을 조절하며 오래, 덜 아프게 사는 것**으로 바뀌는 경우가 많습니다.
- **완화(지지)의료는 마지막 단계의 돌봄이 아닙니다.** 진단 시점부터 항암치료와 함께 통증·피로·숨참·불안을 줄이는 치료입니다.
- 첫 진료에서 "제 치료 목표는 무엇인가요?"를 꼭 물어보세요.

■ 완전판에서 이어집니다

- 치료 목표 대화법, 완화의료·호스피스 이용법, 사전연명의료의향서, 치료를 쉬는 선택
- 2차 소견 받는 법, 병원 선택 기준, 다학제 진료, 임상시험 찾는 법

PART 3. 30일 실행 로드맵

■ **완전판에서 이어집니다** — 30일 실행 로드맵(일자별 체크리스트)

PART 4. 치료 중·후의 몸과 마음

숨참·기침·체력

30초 요약: 숨참과 피로는 흔하지만 관리할 수 있습니다. **호흡재활**과 가벼운 걷기는 도움이 됩니다. 갑자기 심해진 숨참은 2장의 응급 신호입니다.

■ **완전판에서 이어집니다** — 호흡재활·체력 관리 가이드

추적

- 수술·근치 치료 후에는 정기 흉부 CT로 추적합니다(간격은 병기·치료에 따라).
- 4기는 치료 반응 평가 CT를 정해진 간격으로 찍습니다. 면역치료 초기에 종양이 일시적으로 커 보이는 경우(가성진행)도 있어 판단은 의료진이 합니다.
- 금연은 진단 후에도 의미가 있습니다.

■ **완전판에서 이어집니다** — 치료 중 증상별 자가관리 표(메스꺼움·피로·입안 혈음·변비·설사·불면·탈모·피부·손발 저림)

마음 돌보기

30초 요약

- 진단 후 불안, 잠 못 들, 멍함, 화, 눈물은 **흔하고 자연스러운 반응**입니다. 약해서가 아닙니다.
- 2주 넘게 일상이 무너지거나, 스스로를 해치고 싶은 생각이 들면 **혼자 견디지 말고** 바로 도움을 요청하세요.
- 자살·정신건강 위기 상담 ☎ **109**(24시간), 응급 ☎ **119**
- 지금 마음의 고통은 0~10 중 ____ 점. 4점 이상이면 다음 진료에서 그대로 말하세요.

■ 완전판에서 이어집니다

- 고통 온도계, 불안을 다루는 5분 방법, 상담 연결 경로, '내 탓' 생각 다루기
- 보호자 역할 나누기, 아이에게 알리는 법, 보호자 휴가 제도, 보호자 자신의 돌봄
- 직장 병행 전략, 회사에 말하는 범위, 복귀 계획
- 치료 중 식사·운동 원칙과 피해야 할 것

PART 5. 돈 · 서류 · 제도

한국에서 꼭 챙길 제도와 서류

30초 요약

1. **산정특례 등록**: 암 확진 후 **30일 이내**에 신청하면 확진일부터 건강보험 본인부담이 크게 줄어듭니다(급여 항목 기준 5%). 진단받은 병원 원무과에 "산정특례 신청"을 오늘 물어보세요.
2. **서류는 처음부터 두 부씩**: 병리보고서, 영상 판독지, 진단서는 보험·회사·2차 소견에 반복해서 쓰입니다.
3. **제도는 바뀝니다**: 금액·기준은 2026년 10월 기준이며, 공단(1577-1000)·원무과에서 다시 확인합니다.

■ **완전판에서 이어집니다** — 산정특례 신청 절차, 의료비 지원제도, 실손·암보험 서류, 회사 서류 체크리스트

PART 6. 진료실 도구

진료실 질문 모음 — 한 번에 3개씩

진단 직후에는 1~3번, 치료를 정할 때는 4~7번, 치료 시작 전후에는 8~10번 중 3개만 골라 가세요. 보호자가 답을 적으면 충분합니다.

- 1. 확진인가요? 비소세포인가요, 소세포인가요?
- 2. 제 병기는 무엇이고, 뇌 MRI·EBUS가 필요한가요?
- 3. 유전자검사(NGS)와 PD-L1 결과는 무엇인가요?
- 4. 수술이 가능한가요? 수술 전후 약물치료가 필요한가요?
- 5. EGFR·ALK 결과가 치료 순서를 바꾸나요?
- 6. 수술이 어렵다면 방사선(SBRT·항암방사선)은 어떤가요?
- 7. 4기라면 치료 목표와 1차 치료는 무엇인가요?
- 8. 치료 중 바로 연락해야 할 증상은 무엇인가요?
- 9. 제가 참여할 수 있는 임상시험이 있나요?
- 10. 금연·호흡재활·심리 지원은 어디서 받나요?

내 폐암 한 장 요약

항목	내 기록
조직형	선암 / 편평상피 / 소세포 / 기타 _____
병기	임상 _ → 병리 _ (✓/⌚)
림프절	종격동 _ (확인 방법 _)
뇌 MRI	_____
드라이버 변이	EGFR _ ALK _ 기타 _____

항목	내 기록
PD-L1 TPS	____%
첫 치료	수술 / SBRT / 항암방사선 / 표적 / 면역 ± 항암
금연	해당 없음 / 진행 중 / 완료
산정특례	☐ 신청 ☐ 완료

오늘 꼭 물을 3가지: ① 제 조직형과 병기는? ② 유전자·PD-L1 결과는 언제, 무엇인가요? ③ 첫 치료는 무엇이고 언제 시작하나요?

■ 완전판에서 이어집니다

- 같은 진단을 받은 세 사람의 30일(가상 사례)
- 폐암 용어사전
- 폐암 자주 묻는 질문 12
- 진료실 대화법(15분 진료를 30분처럼), 검사 준비 카드(CT·MRI·PET·조직검사·내시경)
- 워크북: 진료 기록지, 7일 증상 일지, 약·보충제 목록, 연락처 카드, 30일 체크 달력

근거와 한계

- **참고 지침:** NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) — Non-Small Cell Lung Cancer / Small Cell Lung Cancer, Version 9.2026(비소세포 기준). NCCN의 표·알고리즘·문장을 옮기지 않고, 환자 언어로 새로 썼습니다.
- **국내 자료:** 국가암지식정보센터(www.cancer.go.kr) 폐암 정보, 대한폐암학회 자료, 국민건강보험공단 산정특례 안내
- **국가암지식정보센터 자료의 이용 방식:** 이 책은 국가암지식정보센터(구 국가암정보센터)의 글·표·그림을 옮기거나 고쳐 신지 않았습니다. 같은 사실을

대조·확인하는 데 참고했고, 문장은 ApuDa가 새로 썼습니다(센터 저작권 안내의 이용조건: 비영리·저작권 표시·내용 변경 금지·영리 이용 시 사전 협의를 따릅니다).

- 출처 : 보건복지부 · 국립암센터 국가암지식정보센터 — 사실 확인에 참고한 자료(센터 문장·그림은 신지 않음). 더 자세한 암 정보와 상담은 www.cancer.go.kr, ☎ 1577-8899(평일 9~18시).
- **의학정보 확인일**: 2026.10.04. 약의 국내 허가·급여, 면역치료·표적치료 적용 기준, 제도 금액은 바뀔 수 있습니다.
- **감수**: ApuDa 「첫 30일」 감수단(전문의 30인·환자 36인·편집자문 3인 역할 기반 **AI 사전 검토단**)의 1·2차 검토를 반영했습니다. 이 검토는 실제 면허 의료진의 최종 감수를 대신하지 않습니다. 출판본에는 실제 감수자 명단이 별도 표기됩니다.
- 이 책은 NCCN이 검토·승인한 자료가 아니며, NCCN과 무관한 ApuDa의 독자적 환자교육 저작물입니다.
- 이 자료는 일반적인 환자교육용이며 개인의 진단·처방·치료 결정을 대신하지 않습니다.

완전판에는 이런 내용이 더 있습니다

- 판독지 용어 사전, 수술 범위별 비교
- 바이오마커별 카드와 결과 대기 중 계획표
- 수술 전후 치료 의사결정 시트, 시나리오(가상 사례)
- 수술 전 2주 체크리스트, 입원~퇴원 후 6주 회복 달력
- EGFR 양성 4기 생활 가이드, 면역치료 부작용 카드
- 치료 목표 대화법, 완화의료·호스피스 이용법, 사전연명의료의향서, 치료를 쉬는 선택
- 2차 소견 받는 법, 병원 선택 기준, 다학제 진료, 임상시험 찾는 법
- 30일 실행 로드맵(일자별 체크리스트)

- 호흡재활·체력 관리 가이드
- 치료 중 증상별 자가관리 표(메스꺼움·피로·입안 혈음·변비·설사·불면·탈모·피부·손발 저림)
- 고통 온도계, 불안을 다루는 5분 방법, 상담 연결 경로, '내 탓' 생각 다루기
- 보호자 역할 나누기, 아이에게 알리는 법, 보호자 휴가 제도, 보호자 자신의 돌봄
- 직장 병행 전략, 회사에 말하는 범위, 복귀 계획
- 치료 중 식사·운동 원칙과 피해야 할 것
- 산정특례 신청 절차, 의료비 지원제도, 실손·암보험 서류, 회사 서류 체크리스트
- 같은 진단을 받은 세 사람의 30일(가상 사례)
- 폐암 용어사전
- 폐암 자주 묻는 질문 12
- 진료실 대화법(15분 진료를 30분처럼), 검사 준비 카드(CT·MRI·PET·조직검사·내시경)
- 워크북: 진료 기록지, 7일 증상 일지, 약·보충제 목록, 연락처 카드, 30일 체크달력

ApuDa.app — 더 많은 암·질환 교육 콘텐츠와 업데이트 Instagram 구독자 무료 배포판 · 상업적 재배포 금지

ApuDa | 아프지만, 다행이다. · <https://apuda.app/>